

TEMA 10.5 • REUMATOLOGÍA

Artritis por Cristales: Gota y Condrocálcinosis

PERFIL EUNACOM 1.05.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Las **artritis por cristales** son una causa frecuente de consulta en los servicios de urgencias y medicina interna. Se presentan típicamente como una **monoartritis aguda**, aunque pueden manifestarse como oligoartritis. Las dos entidades principales que todo médico debe dominar para el EUNACOM son la **Gota** y la **Condrocálcinosis** (también conocida como pseudogota).

1. Etiología y Fisiopatología

La inflamación articular en estas patologías no es infecciosa, sino química, mediada por el depósito de microcristales en el espacio sinovial.

- **Gota:** Se produce por el depósito de cristales de **urato monosódico** (ácido úrico). Su causa suele ser una combinación de factores genéticos (predisposición a la hiperuricemia) y factores de estilo de vida (dieta, alcohol).
- **Condrocálcinosis:** Se produce por el depósito de cristales de **pirofosfato de calcio**. Puede ser:
 - **Primaria:** De origen genético.
 - **Secundaria:** Asociada a enfermedades metabólicas, principalmente el **Hiperparatiroidismo** primario (debido a la hipercalcemia), hipomagnesemia o hemocromatosis.

NOTA CLÍNICA

El ácido úrico elevado en sangre (hiperuricemia) es el factor de riesgo principal para la gota, pero no todos los pacientes con hiperuricemia desarrollarán la enfermedad. La inflamación ocurre cuando los cristales precipitan en la articulación y son fagocitados por los neutrófilos, gatillando una respuesta inflamatoria intensa.

2. Comparación Clínica: Gota vs. Condrocálcinosis

TABLA 10.5.1: CARACTERÍSTICA VS GOTA

CARACTERÍSTICA	GOTA	CONDROCALCINOSIS (PSEUDOGOTA)
Cristal	Ácido Úrico (Urato monosódico)	Pirofosfato de Calcio
Localización típica	1º Metatarsofalángica (Podagra)	Rodilla
Hallazgo Crónico	Tofos (depósitos blanquecinos)	Calcificación del cartílago
Birrefringencia	Negativa (forma de aguja)	Positiva (forma romboidal)
Etiología	Genética + Dieta/Alcohol	Genética o Secundaria (Hiperparatiroidismo)

3. Diagnóstico

El estándar de oro para el diagnóstico es el **estudio del líquido articular** mediante artrocentesis.

- **Estudio de cristales:**
 - **Gota:** Cristales amarillos en forma de aguja con **elongación o birrefringencia negativa**.
 - **Condrocálcinosis:** Cristales de forma romboidal con **elongación o birrefringencia positiva**.
- **Imágenes:**
 - **Gota:** En etapas avanzadas se observan erosiones óseas "en sacabocado" y tofos. Los tofos son visibles clínicamente en orejas y dedos.
 - **Condrocálcinosis:** La radiografía de rodilla es clásica, mostrando una línea de calcificación en los meniscos o el cartílago articular

(fibrocartilago).

- **Laboratorio:** Los niveles de ácido úrico pueden estar normales durante un ataque agudo de gota. Los valores normales son:
 - Mujeres: < 6 mg/dL.
 - Hombres: < 7 mg/dL.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Ante una monoartritis aguda, siempre se debe realizar el diagnóstico diferencial con una **Artritis Séptica**. Si existe duda razonable o el cuadro es muy febril y tóxico, se debe manejar como infeccioso hasta que el cultivo de líquido articular demuestre lo contrario.

4. Tratamiento de la Gota

Manejo del Ataque Agudo

El objetivo es el control del dolor y la inflamación. Las opciones son:

- **Corticoides:** Actualmente son la recomendación internacional de primera línea (ej. Prednisona oral).
- **AINES:** Muy utilizados en Chile (ej. Ketorolaco, Diclofenaco, Ketoprofeno). Son altamente efectivos pero requieren precaución en pacientes con falla renal o riesgo gástrico.
- **Colchicina:** Útil en dosis bajas, aunque se usa menos que los anteriores debido a sus efectos adversos gastrointestinales.

Profilaxis de Recurrencia (Tratamiento Crónico)

Se indica habitualmente cuando el paciente presenta **2 o más crisis en un año** o tiene niveles de ácido úrico muy elevados con tofos.

1. **Cambios en el estilo de vida:** Dieta baja en carnes rojas, mariscos y bebidas alcohólicas (especialmente la cerveza).
2. **Alopurinol:** Es un inhibidor de la xantina oxidasa. Es el fármaco de elección por su bajo costo y eficacia. La dosis debe ajustarse hasta alcanzar niveles de ácido úrico < 6 mg/dL.
3. **Febuxostat:** Alternativa para pacientes con contraindicación o alergia al Alopurinol.
4. **Uricosúricos (Probenecid):** Aumentan la excreción de ácido úrico. Son de segunda línea y menos eficaces.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Mito del Alopurinol: Tradicionalmente se enseñaba que nunca se debe iniciar o cambiar la dosis de Alopurinol durante un ataque agudo por riesgo de exacerbarlo. Actualmente se sabe que esto no es estrictamente cierto, aunque lo habitual sigue siendo esperar a que pase la crisis para iniciar la terapia de mantención.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Los **uricosúricos** (como el Probenecid) están **absolutamente contraindicados** en pacientes con antecedentes de **litiasis renal por ácido úrico**, ya que al aumentar la excreción urinaria favorecen la formación de nuevos cálculos. El Alopurinol, en cambio, disminuye el riesgo.

5. Tratamiento de la Condrocálcinosis

Manejo Agudo

- **Artrocentesis aspirativa:** La medida más eficaz es aspirar el líquido inflamatorio e inyectar **corticoides intraarticulares**.
- **Sistémico:** Si no es posible la infiltración, se utilizan AINES, corticoides orales o colchicina, de forma similar a la gota.

Profilaxis

No existe un tratamiento tan eficaz como el Alopurinol para la condrocálcinosis.

- **Tratar la causa secundaria:** Si existe un **Hiperparatiroidismo**, la cirugía de paratiroides puede ayudar.
- **Colchicina:** Se indica como profilaxis si el paciente presenta **3 o más crisis al año**.

6. Hiperuricemia Asintomática

- Si un paciente presenta niveles elevados de ácido úrico pero **nunca ha tenido una crisis de gota**:
- **No se indica Alopurinol.**
- Solo se indican medidas no farmacológicas (dieta y cambios en estilo de vida).
- El tratamiento farmacológico solo se inicia ante la presencia de clínica (gota o litiasis).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Recuerda para el EUNACOM: - **Gota**: Podagra, cristales en aguja, birrefringencia negativa, Alopurinol. - **Condrocálcinosis**: Rodilla, calcificación de meniscos, cristales romboidales, birrefringencia positiva.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente con gota que presenta 3 crisis en el último año. Tiene antecedente de litiasis renal por ácido úrico. ¿Cuál fármaco está contraindicado para la profilaxis?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Artritis por Cristales: Gota y Condrocálcinosis. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Gota: cristales de ácido úrico, birrefringencia negativa, afecta primera metatarsofalángica (podagra), genera tofos
- Condrocálcinosis: cristales de pirofosfato de calcio, birrefringencia positiva, afecta rodilla, calcifica cartílago en radiografía
- Tratamiento agudo de gota: corticoides (recomendación internacional), AINEs (más usado en Chile) o colchicina en dosis bajas
- Profilaxis de gota: dieta hipouricemiante + alopurinol desde 2 crisis/año
- Es un mito que el alopurinol no pueda iniciarse en agudo, pero tampoco aporta beneficio en ese momento
- Uricosúricos están contraindicados en litiasis por ácido úrico
- Hiperuricemia asintomática: solo cambio de estilo de vida, no alopurinol
- Condrocálcinosis aguda: aspiración + corticoides intraarticulares es lo óptimo

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ARTRITIS POR CRISTALES: GOTA Y CONDRÓCALCINOSIS)

PREGUNTA 1

Paciente con gota que presenta 3 crisis en el último año. Tiene antecedente de litiasis renal por ácido úrico. ¿Cuál fármaco está contraindicado para la profilaxis?

- A) Alopurinol
- B) Febuxostat
- C) Probenecid
- D) Colchicina
- E) Prednisona

PREGUNTA 2

Paciente con hiperuricemia de 8.5 mg/dL sin antecedentes de crisis de gota. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A) Iniciar alopurinol inmediatamente
- B) Iniciar colchicina profiláctica
- C) Indicar cambio de estilo de vida y dieta hipouricemiante
- D) Iniciar febuxostat
- E) Iniciar probenecid

PREGUNTA 3

Paciente de 75 años con monoartritis aguda de rodilla. La radiografía muestra calcificación de meniscos. ¿Cuál es el tratamiento agudo más eficaz?

- A) AINEs orales
- B) Colchicina en dosis bajas
- C) Alopurinol
- D) Aspiración del derrame + corticoides intraarticulares
- E) Prednisona oral

RESUMEN: ARTRITIS POR CRISTALES: GOTA Y CONDROCALCINOSIS

Esta clase detalla la gota y la condrocalcinosis como las dos causas principales de artritis por cristales. La gota produce depósitos de ácido úrico (cristales de birrefringencia negativa, afecta la primera metatarsofalángica - podagra, genera tofos a largo plazo). La condrocalcinosis produce cristales de pirofosfato de calcio (birrefringencia positiva, afecta la rodilla, calcifica el cartílago visible en radiografía). El tratamiento agudo de la gota incluye corticoides (recomendación internacional actual), AINEs (lo más usado en Chile) y colchicina en dosis bajas. La profilaxis de recurrencia se indica con 2 o más crisis al año, mediante dieta hipouricemiante más alopurinol (inhibidor de xantina oxidasa). El inicio o cambio de dosis de alopurinol en agudo es un mito que no aumenta el riesgo, aunque tampoco aporta beneficio. La hiperuricemia asintomática solo se trata con cambio de estilo de vida. El tratamiento agudo de la condrocalcinosis es aspiración del derrame más corticoides intraarticulares (óptimo), o manejo similar a la gota. La profilaxis con colchicina se indica desde 3 crisis. Los uricosúricos están contraindicados en litiasis por ácido úrico.